

REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Université Constantine 3
Salah Bounider
Faculté De Médecine
Département De Médecine
Enseignement de 3ème année médecine.
Année universitaire 2024-2025.



Cours de sémiologie cardiaque :

Syncope et Lipothymies

Dr Yazid Chettibi
Maitre-assistant en Médecine Interne- HMRUC

Les syncopes et les lipothymies

I- Les syncopes :

1) Définition :

La syncope est une perte de connaissance brusque, complète et passagère liée à une anoxie cérébrale, s'accompagnant d'une perte de tonus postural.

2) Description :

Elle se manifeste comme un accident subit avec perte brutale et totale de la conscience, sans prodromes.

Si le sujet est debout au moment de l'accident, elle s'accompagne d'une chute sur le sol :

Le malade présente une pâleur extrême du visage, le pouls artériel n'est pas perceptible et la tension artérielle est imprenable, la respiration peut être arrêtée. Le malade est soit calme en état de relâchement musculaire complet, soit agité présentant des secousses musculaires avec parfois perte des urines.

Récupération rapide de l'état de conscience : la durée de cette perte de conscience est courte : quelques secondes à une minute ; la récupération totale est immédiate : elle est circulatoire, réapparition des pouls et remontée de la TA et neurologique : reprise totale de la conscience et de la motricité.

3) Physiopathologie :

Une syncope peut être déclenchée par **une hypoperfusion cérébrale globale et transitoire**, quel que soit le mécanisme.

L'intégrité d'un certain nombre de mécanismes de contrôle est essentielle pour maintenir un apport d'oxygène cérébral suffisant.

Le risque de syncope est plus grand chez les personnes âgées ou chez les patients ayant des pathologies sévères ou fréquentes.

4) Diagnostic différentiel :

- L'arrêt cardio-respiratoire : état de mort apparente, abolition de pouls carotidien et fémoral, hypotonie généralisée, absence de ventilation spontanée, absence de réponse à la stimulation.
- L'accident ischémique transitoire (AIT) : qui est une perte de connaissance sans troubles circulatoires, on peut trouver des signes neurologiques de focalisation.
- La crise comitiale : (épilepsie) qui est une perte de connaissance s'accompagnant de convulsions, morsure de la langue, amnésie post critique, mais sans troubles circulatoires.
- Coma : perte de connaissance non réversible par les stimulations, liée à un dysfonction cérébrale sévère.

- Métabolique : hypoglycémie, hypokaliémie, intoxication au monoxyde de carbone...

5) Etiologies :

Les causes des syncopes sont soit cardiaques, soit extracardiaques :

α) Les causes cardiaques :

- ❖ La syncope du syndrome d'Adams-Stokes : elle survient spontanément surprenant le sujet aussi bien en pleine activité qu'au repos complet, elle est en rapport avec un bloc auriculo-ventriculaire complet.
- ❖ Troubles de rythme cardiaque : tachycardies, bradycardies sévères.
- ❖ La syncope d'effort : survient à la marche rapide ou lors de la montée des escaliers, elle se voit essentiellement au cours du rétrécissement aortique, et cardiopathies obstructives.
- ❖ D'autres cardiopathies peuvent se compliquer de syncopes : myxome de l'oreillette, thrombose sur valve mécanique.

β) Les causes extracardiaques :

- ❖ L'hypotension orthostatique idiopathique (sans cause décelable) ou iatrogène (due à l'administration d'un médicament, le plus souvent traitement hypotenseur).
- ❖ L'hyper-réflexivité du sinus carotidien : elle est provoquée par une pression externe du sinus carotidien ; elle réalise une syncope brusque et brève durant quelques secondes. Elle peut être provoquée sur le malade couché par une pression exercée sur la bifurcation carotidienne.
- ❖ Syncope vaso-vagale : (syncope réflexe).

6) Conduite à tenir :

Chez tout malade ayant présenté une syncope, on devra systématiquement faire :

- Un interrogatoire minutieux,
- Un examen clinique : en auscultant le cœur à la recherche d'un souffle, compter la fréquence cardiaque, mesurer la tension artérielle en position couchée et en position debout (à la recherche d'une hypotension orthostatique),
- et faire un ECG.

II- Les lipothymies :

Sont plus fréquentes que les syncopes vraies avec lesquelles elles sont le plus souvent confondues.

Elles doivent être différenciées des syncopes. La signification pathologique de ces deux événements est cependant la même, et une lipothymie doit être explorée avec autant de soins qu'une syncope vraie.

La lipothymie est précédée de troubles sensoriels : troubles visuels, bourdonnements d'oreille ou bruits de tintements de cloche, de sueurs et de pâleur. Elle a un début progressif qui permet au malade de s'allonger pour éviter la chute. La perte de connaissance est incomplète.

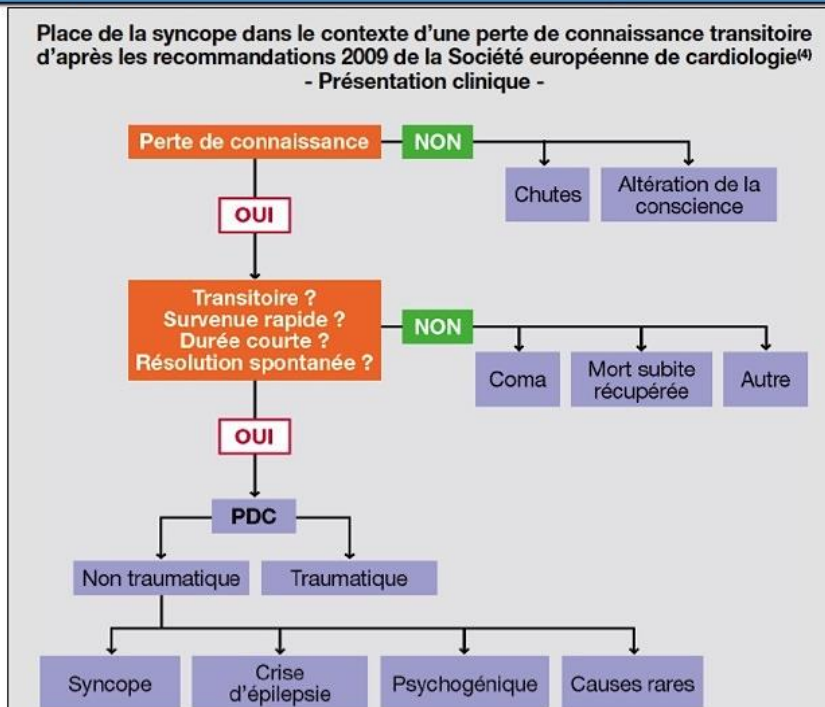
Le malade est pâle, le pouls est petit et lent.

La durée est variable de quelques minutes à une demi-heure, la reprise de la conscience est progressive ; elle est suivie d'un état de fatigue qui peut persister plusieurs heures.

Le mécanisme des lipothymies est le même que la syncope, mais la durée de l'hypoperfusion cérébrale est trop brève pour entraîner une perte de connaissance complète.

Syncope

Les pertes de connaissance (ESC 2009)



Rythmes • Janv 2012
Dr Claude Kouakam